

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	跌倒防範及處置評核表	編 號	A31000-Q07-F-006
			版 本	第 3.5 版
	制定 單位	護理部	修正日期	115 年 01 月 13 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：各單位護理人員（含中興分院）。

（不適用單位：ER、OR、HD、BR、PICU、NICU、IR、ICU、RCC、OPD、RCW）。

二、評核方式：

實地觀察並查核護理記錄。

三、評核內容：

1. 實地查核（查核一位跌倒危險因子評估 ≥ 4 分病人）或口述。

a. 佩戴粉紅色手圈。

b. 床頭懸掛預防跌倒標語(※復健科病人 ≥ 7 分才掛防跌標誌)。

c. 叫人鈴置於伸手可及之處，並能正確操作。

d. 常用物品置於床旁桌伸手可及之處。

e. 床欄至少拉起三側(推床需拉起二側)。

2. 詢問高跌病人或主要照顧者能說出至少 2 項預防跌倒的方法(a~d)。

a. 給予鎮靜安眠藥時，說出藥物可能的作用及注意事項。

b. 主動提醒或協助病人臨睡前如廁之需求。

c. 夜間將尿壺或便盆擺放在病床旁易取得之位置。

d. 地板溼滑應立即通知護理站。

3. 詢問護理人員或查閱護理紀錄，於病人跌倒後有檢視及調整照護計畫

a. 跌倒病人重新評估危險因子並適時調整照護措施

b. 頻尿或腹瀉病人應檢視其飲食、用藥情形或疾病史，如前列腺肥大或尿道感染，適時處理。

c. 評估造成病人躁動原因，給予適當保護措施。

d. 若移位困難，需適時提供輔具。

e. 多重用藥應檢視藥品使用必要性，並適時調整。

4. 查核護理紀錄。

a. 病人入院 8 小時內完成跌倒危險因子評估。

b. 65 歲(含)以上病人，於入院或轉入 72 小時內完成衰弱評估。

c. 每週、轉入、發生跌倒、病情改變時、全麻手術後、出院前 24 小時須重新進行跌倒危險因子評估。

d. 護理紀錄有呈現第一天給藥前(鎮靜安眠藥)衛教內容及藥物使用後病人狀況。

e. 跌倒危險因子評估 ≥ 4 分需有預防跌倒衛教記錄、高危險性跌倒之護理措施(※兒科 ≥ 6 分才下護理措施)。

f. 衰弱評估 ≥ 1 分需有衰弱衛教記錄。

g. 當臥床病人第一次下床時，應有執行步態平衡測試之護理紀錄。

